RSV 백신 상담
독감 백신과 다른가요?

접종 대상·시기·반복 접종·효과와 위험을 구분해서 이해합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

RSV는 어르신에게도 중요한 호흡기 감염입니다

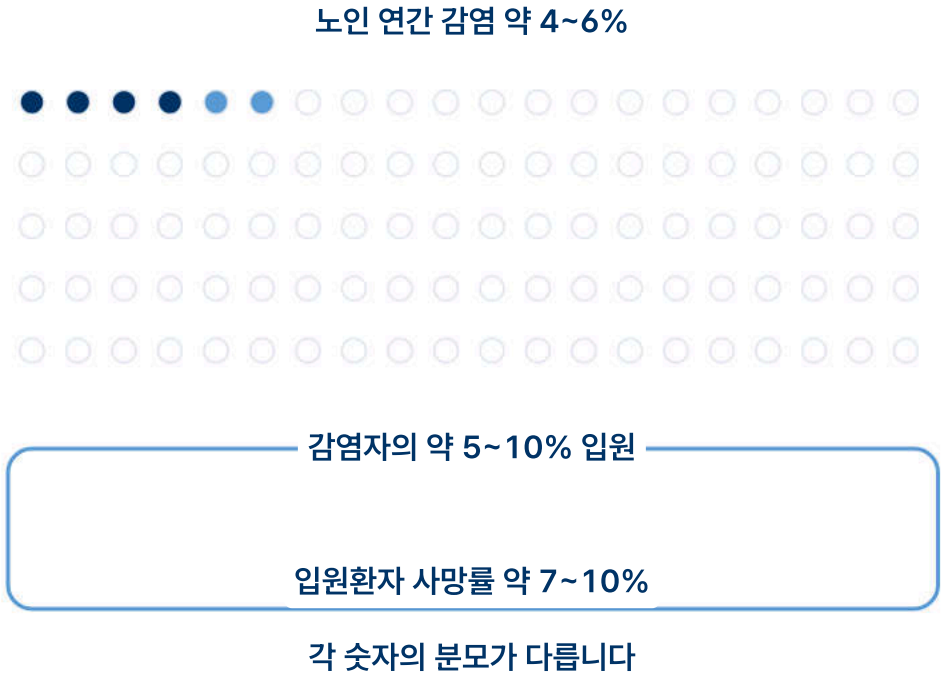
강의에 소개된 국내 노인 감염 추정치입니다

감염과 입원

국내 노인의 연간 감염은 약 4~6%, 감염자의 약 5~10%가 입원하는 것으로 소개됐습니다. 입원환자 사망률은 약 7~10%, 연간 사망 약 500~2,000명으로 추정했습니다.

독감과 같은 바이러스는 아닙니다

강의는 RSV 질병 부담을 독감의 약 1/2~2/3 정도로 소개했고, 비슷하다는 보고도 언급했습니다. RSV 백신과 독감 백신은 각각의 감염을 대상으로 설명합니다.



강의에 소개된 국내 노인 감염 추정치입니다 · 설명용 도식

강의에 소개된 국내 노인 감염 추정치입니다

중환자실 연구의 숫자는 일반 감염 위험과 다릅니다

연구 대상과 평가 시점을 함께 봅니다

중환자실 성인 연구

서울아산병원 2010년 3월~2019년 2월 자료는 RSV 폐렴 92명과 독감 폐렴 163명을 비교했습니다. RSV 환자는 독감 환자 수의 56.4%였습니다.

중증 환자에서의 결과

기계환기를 받은 비율은 96.7%와 97.6%였습니다. 여러 시점의 사망률이 28.2~52.8% 범위에서 유사했고 면역저하가 위험인자였습니다. 이 중환자실 결과를 모든 RSV 감염자의 사망 위험으로 읽지 않습니다.

연구 대상과 평가 시점을 함께 봅니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의의 RSV 권고는 나이와 중증 위험을 나눕니다

2026년 강의에서 소개한 대한감염학회 권고입니다

75세 이상

모든 성인에게 RSV 백신 1회 접종을 권고하는 것으로 제시됐습니다.

50~74세 고위험군

중증 RSV 감염 위험이 높은 경우 1회 접종을 권고합니다. 독감처럼 모든 성인에게 일률적으로 설명하는 백신과 구별하고, 나이뿐 아니라 기저질환과 생활 환경도 함께 살핍니다.

75세 이상

전체 성인 · 1회

50~74세

중증 RSV 고위험군 · 1회

2026년 강의에서 소개한 대한감염학회 권고입니다 · 설명용 도식

2026년 강의에서 소개한 대한감염학회 권고입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

고위험군에는 이런 조건이 포함됩니다

단순 고혈압은 만성 심혈관질환 항목에서 제외됩니다

심혈관·폐질환

만성 심혈관질환(단순 고혈압 제외),
만성 폐·호흡기질환

말기 콩팥질환

말기 신장질환 또는 혈액투석·다른 신대체요법 의존

당뇨병

장기 손상 동반 또는 인슐린·SGLT2 억제제 치료가 필요한 경우

신경·신경근육질환

기도 청소 장애 또는 호흡근 약화를 유발하는 경우

간·혈액질환

만성 간질환(간경변), 겸상적혈구병·지중해빈혈 등 만성 혈액질환

그 밖의 위험

BMI ≥40 kg/m², 중등도·중증 면역저하,
요양시설 거주

> 단순 고혈압은 만성 심혈관질환 항목에서 제외됩니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

허가 대상과 접종 권고 대상은 다릅니다

강의에 제시된 국가·제품·시점을 나눠 봅니다

구분	설명
국내 Arexvy 허가 · 강의 시점	60세 이상 전체, 50~59세 중증 감염 고위험군
대한감염학회 권고 · 강의 시점	75세 이상 전체, 50~74세 중증 RSV 고위험군에 1회
미국 FDA 허가 · 강의 표	세 제품 모두 60세 이상 전체와 18~59세 고위험군
Abrysvo · 국내 시점	강의에서는 2026년 하반기 허가 예정으로 소개. 미국 허가와 국내 허가를 구별

여기의 허가·권고 설명은 2026년 9월 강의에 제시된 시점의 내용입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

임신부 접종은 별도의 목적과 조건입니다

미국 Abrysvo 기준과 국내 예정 설명을 구분합니다

미국에서 소개된 조건

강의는 Abrysvo가 임신 32~36주에 허가·권고된다고 설명했습니다. 어머니의 항체가 전달되어 신생아의 RSV 위험을 낮추기 위한 전략입니다.

국내에 대한 강의 설명

연자는 2026년 하반기 국내 허가가 되면 임신부 접종도 추천될 것으로 예상했습니다. 이 예상 발언을 국내에서 이미 확정된 허가나 권고로 바꾸어 이해하지 않습니다.

미국 Abrysvo 기준과 국내 예정 설명을 구분합니다

RSV 백신은 융합 전 F단백을 표적으로 합니다

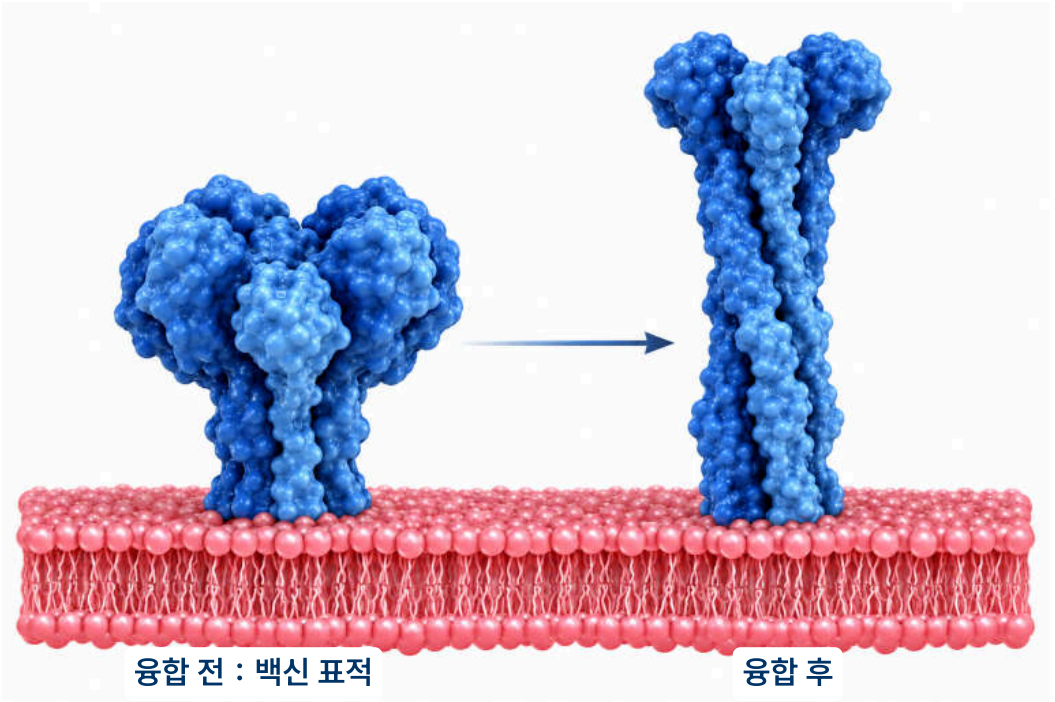
바이러스가 호흡기 세포에 들어가는 과정을 막는 표적입니다

F단백의 역할

RSV 표면의 F단백은 바이러스가 호흡기 세포와 융합해 들어가는 데 중요한 역할을 합니다. 세포와 결합 전인 prefusion과 결합 후인 postfusion은 모양이 다릅니다.

융합 전 형태를 이용

백신은 중화에 중요한 항원 부위가 드러난 prefusion F단백을 이용합니다. 강의는 Site Ø·V 같은 부위에 대한 항체가 만들어지는 과정을 설명했습니다. 항체 반응과 실제 감염 예방 효과는 구분해서 평가합니다.



바이러스가 호흡기 세포에 들어가는 과정을 막는 표적입니다 · 설명용 도식

> 바이러스가 호흡기 세포에 들어가는 과정을 막는 표적입니다

제품은 구성과 제조 방식이 다릅니다

항원의 양을 단순히 효과의 크기로 비교하지 않습니다

Arexvy · GSK

RSV-A preF 단백항원 120 μg과 AS01E 면역증강제를 포함합니다. 강의는 A·B의 단백 서열이 유사하다고 설명했습니다.

Abrysvo · Pfizer

RSV-A 60 μg + RSV-B 60 μg의 preF 단백항원을 포함하는 2가 백신입니다. 별도 면역증강제는 포함하지 않습니다.

mRESVIA · Moderna

RSV-A preF를 만드는 mRNA-1345 50 μg을 포함합니다. 별도 면역증강제는 없고 mRNA·지질입자 자체의 면역 자극이 소개됐습니다.

> 항원의 양을 단순히 효과의 크기로 비교하지 않습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

효능과 효과는 평가하는 환경이 다릅니다

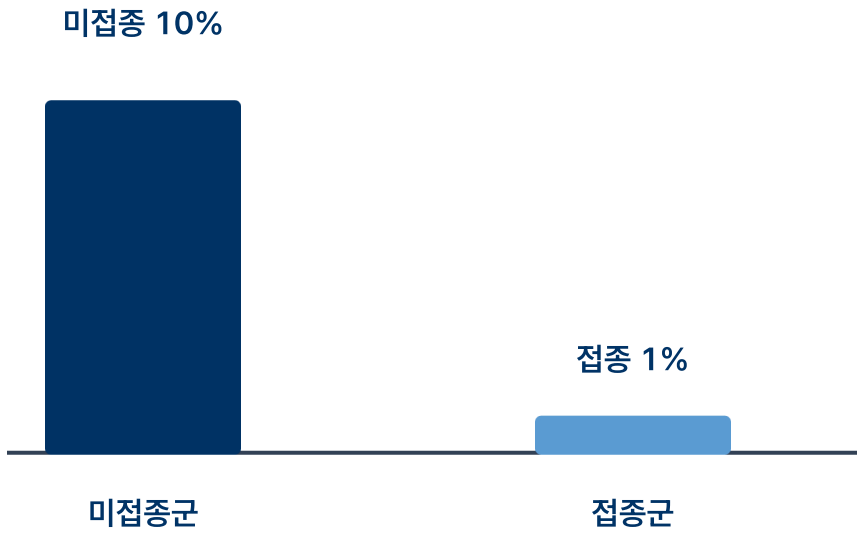
백신 숫자를 볼 때 무엇을 얼마나 줄였는지 확인합니다

효능 · efficacy

임상시험 환경에서 질병 발생의 상대위험이 얼마나 줄었는지입니다. 강의 예시: 미접종 감염률 10%, 접종 감염률 1%이면 상대위험은 1/10이고 효능은 90%입니다.

효과 · effectiveness

실제 진료 환경에서 추정한 예방 정도입니다. 사람들의 차이, 수송·보관, 유행 바이러스 등 영향을 받습니다. 항체 반응인 면역원성(immunogenicity)도 실제 질병 예방과는 평가 항목이 다릅니다.



백신 숫자를 볼 때 무엇을 얼마나 줄였는지 확인합니다 · 설명용 도식

> 백신 숫자를 볼 때 무엇을 얼마나 줄였는지 확인합니다

한 임상시험에서도 예방 결과는 항목마다 다릅니다

Arexvy AReSVi-006 시험: 60세 이상 24,966명

하기도 질환

효능 82.6% (95% CI 57.9~94.1). RSV-A 84.6%, RSV-B 80.9%로 소개됐습니다.

중증 하기도 질환

효능 94.1% (95% CI 62.4~99.9). 일반 감염 예방과 다른 평가항목입니다.

급성 호흡기 감염

효능 71.7% (95% CI 56.2~82.3). 한국 포함 17개국 278기관, 백신 12,467명·위약 12,499명 비교입니다.

Arexvy AReSVi-006 시험: 60세 이상 24,966명

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

서로 다른 제품 시험의 숫자는 순위를 뜻하지 않습니다

대상·증상 수·평가항목과 추적 기간이 다릅니다

구분	설명
Arexvy · AReSVi-006	하기도 질환 82.6%, 중증 하기도 질환 94.1%, 급성 호흡기 감염 71.7%
Abrysvo · RENOIR	하기도 질환 85.7%와 증상 ≥2개 기준 66.7%, 급성 호흡기 감염 62.1%
mRESVIA · ConquerRSV	하기도 질환 83.7%와 증상 ≥2개 기준 68.4%, 급성 호흡기 감염 68.4%
해석	같은 사람들을 대상으로 제품끼리 직접 비교한 결과가 아닙니다. 다른 조건의 수치로 우열을 정하지 않습니다.

대상·증상 수·평가항목과 추적 기간이 다릅니다

RSV는 독감처럼 매년 반복 접종하지 않습니다

강의의 2026 권고는 RSV 백신 1회입니다

RSV · 강의 권고

연중 접종이 가능하고 유행을 고려하면 8~10월이 바람직하다고 설명합니다. 정기적인 반복 접종은 권고하지 않으며, 이미 맞은 기록이 중요합니다.

독감 · 연자 Q&A

성인은 같은 유행철에 1회 접종이 원칙이라고 답했습니다. 서로 다른 독감 백신을 1~2개월 간격으로 두 번 맞는 이득·안전성은 입증되지 않았다고 설명합니다.

강의의 2026 권고는 RSV 백신 1회입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

접종 시기는 유행을 고려해 정합니다

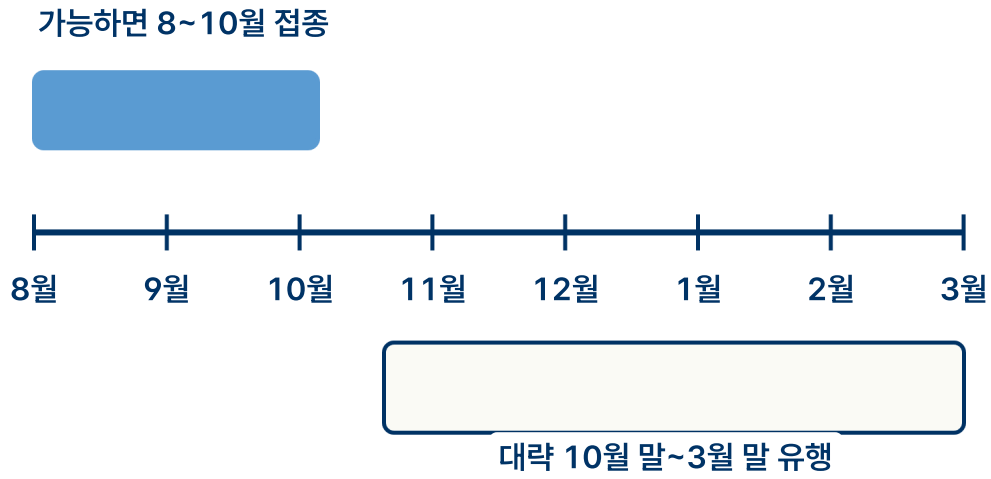
강의에 소개된 온대지역·국내 감시 자료의 계절성입니다

유행 시기의 차이

온대지역에서 RSV는 독감보다 약 보름~한 달 먼저 시작하고 약 한 달 먼저 끝나는 것으로 설명됐습니다.

국내 계절성과 접종

강의에서는 국내 RSV가 대략 10월 말 시작해 3월 말 끝난다고 설명합니다. 이를 고려해 8~10월 접종을 권했지만, 접종 대상자는 연중 어느 때든 1회 접종할 수 있다고 제시했습니다.



대상자는 연중 어느 때든 1회 접종 가능

강의에 소개된 온대지역·국내 감시 자료의 계절성입니다 · 설명용 도식

강의에 소개된 온대지역·국내 감시 자료의 계절성입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

다음 해 한 번 더 맞는 이득은 뚜렷하지 않았습니다

Arexvy 3시즌 연구에서 단회·재접종을 각각 위약과 비교했습니다

연구 구성

첫 시즌 접종군을 둘째 시즌 전에 1:1로 나눠 재접종 또는 단회 접종군으로 추적했습니다. 셋째 시즌의 추가 접종은 중단하고 관찰했습니다.

3시즌 누적 효능

단회 62.9%(97.5% CI 46.7~74.8), 재접종 69.8%(42.2~85.7)로 소개됐습니다.

결과 해석

셋째 시즌은 단회 48.0%, 재접종 68.4% 경향이었으나 신뢰구간이 겹쳤습니다. 두 군 직접 비교가 아닌 위약 대비 비교여서 의미 있는 차이로 단정하기 어렵다고 설명합니다.

Arexvy 3시즌 연구에서 단회·재접종을 각각 위약과 비교했습니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

예방 정도는 시간이 지나며 달라집니다

제품별 추적 기간과 평가 정의를 함께 봅니다

구분	설명
Arexvy · 3시즌	1시즌 82.6%, 2시즌 56.1%, 3시즌 48.0%; 누적 2시즌 67.2%, 3시즌 62.9%
Abrysvo · 2시즌	1시즌 85.7%(66.7%), 2시즌 77.8%(55.7%); 누적 81.5%(60%). 괄호는 증상 기준 차이
mRESVIA · 18~24개월	3.7개월 83.7%, 8.6개월 62.5%, 12개월 56%; 12~24개월 30%, 24개월 누적 47.4%
상담에 쓰는 의미	감소 추세가 있다고 바로 정기 재접종이 필요하다는 뜻은 아닙니다. 강의는 추가접종 권고를 연구 자료와 구분합니다.

제품별 추적 기간과 평가 정의를 함께 봅니다

실제 진료 연구에서도 입원·응급실 예방을 봤습니다

임상시험 효능과 다른 설계의 효과 추정입니다

미국 VISION 연구

2023년 10월~2024년 3월, 8개주 230병원·245응급실, 60세 이상 RSV 유사 증상 검사자 대상입니다.

검사음성 대조 설계

RSV 검사 양성·음성군의 접종 차이를 이용해 추정했습니다. 입원 효과 80%(95% CI 71~85), 응급실 효과 77%(70~83)였습니다.

지속성 연구

미국 재향군인 60세 이상 관찰연구는 접종 288,111명·대조 1,075,893명을 2시즌 추적했습니다. 12개월 효과는 감염·응급실·입원 70%대, ICU 입원 약 80%로 소개됐습니다.

임상시험 효능과 다른 설계의 효과 추정입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

드문 신경계 이상반응도 함께 설명합니다

길랭-바레증후군(GBS)의 추가 발생 추정치입니다



강의의 100만 회당 추정

Arexvy 5.2건(-0.9~9.2), Abrysvo 18.2건(9.8~23.3), 독감 백신 1~2건이 소개됐습니다. 드문 사건의 추정 범위까지 함께 봅니다.



다른 분석의 조건

미국 2024 추정은 60세 이상 단백 백신 100만 회·2시즌에 대한 자료입니다. 예방 사망 약 1,000명과 GBS 추가 약 3~16건을 함께 제시했습니다. 위 표와 분석 조건이 다릅니다.



상담의 초점

중증 감염을 막는 이득과 드문 이상반응 위험을 함께 봅니다. 한 자료의 숫자만으로 모든 연령·모든 제품에 같은 이득과 위험을 적용하지 않습니다.

길랭-바레증후군(GBS)의 추가 발생 추정치입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

이미 맞았다면 제품명과 날짜부터 봅니다

연자 Q&A의 재접종·비용 상담입니다

다른 RSV 제품을 추가할까요

연자 Q&A: Arexvy 1회 접종 후 Abrysvo를 다시 접종하도록 권고하지 않는다고 답했습니다. 현 시점 1회 원칙과 교차 추가접종의 이득·부작용을 구분해 설명했습니다.

비용 때문에 고민될 때

연자는 75세 이상 또는 만성 심폐질환·면역저하 등 위험이 높은 50~74세에서는 가격이 높더라도 접종을 적극 설명할 가치가 있다고 답했습니다. 이는 연자 Q&A의 상담 의견입니다.

연자 Q&A의 재접종·비용 상담입니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

진료에서 나이·위험·접종 기록을 함께 확인합니다

RSV 상담과 독감 상담을 각각 정리합니다

01 내 위험 조건

나이와 만성질환·면역저하·요양시설 거주 여부를 확인합니다.

02 맞은 기록

RSV 백신의 제품명과 날짜, 독감의 해당 유행철 접종 기록을 확인합니다.

03 접종 계획

허가와 권고를 구분하고, 강의 시점의 1회 원칙과 접종 시기를 설명받습니다.

04 기대와 위험

중증 감염 예방, 드문 GBS, 개인 비용을 함께 이야기합니다.

RSV 상담과 독감 상담을 각각 정리합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

내 상태에 맞는 다음 진료를 함께 정합니다

접종 대상·시기·반복 접종·효과와 위험을 구분해서 이해합니다

전화

031-893-4560

주소

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298,
4층 402-404호

진료시간

평일(월–금) 08:30~18:30
점심 13:00~14:00 · 토 08:30~13:30
일·공휴일 휴진

진료과

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

광교바른내과
진료 설명자료

광교바른내과 · 환자·보호자 설명자료